

26. PRATIQUE : LES POUMONS

DURÉE : 05:35

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo se concentre sur l'approche biodynamique des poumons, en mettant l'accent sur la manière dont le mouvement de bascule des poumons et la recherche du point de fulcrum embryonnaire sont essentiels pour restaurer leur fonction primaire. Les participants apprendront à observer la dynamique entre les poumons, la plèvre et le tissu environnant, notamment comment les émotions, telles que la tristesse, peuvent s'y loger et influencer la respiration. Des techniques visant à initier un dialogue tissulaire et à libérer les espaces pleuraux bondés d'exsudats sont également abordées, en soulignant l'importance de la réorganisation structurelle et émotionnelle des poumons pour améliorer la santé respiratoire.

PRATIQUE DES POUMONS

La **main postérieure** est légèrement plus basse que la **main antérieure**, qui est légèrement plus haute. Cela est dû au mouvement de **bascule** des poumons sur leur axe. Ce mouvement est essentiel pour se placer dans le **champ embryonnaire** des poumons, où l'on recherche le **point de fulcrum embryonnaire**. Ce point représente un champ d'aspiration, permettant de se repotentialiser dans la fonction primaire des poumons, c'est-à-dire être prêt à **prendre le souffle de vie**.

Durant les neuf mois de développement embryonnaire, les poumons sont préparés à ce premier mouvement. Ils fabriquent du **liquide amniotique**, une fonction cruciale car l'embryon en a besoin pour sa survie. Ce liquide est en partie issu de l'urine des reins. Plus tard, une **protéine spécifique** appelée **surfactant** sera produite, permettant l'ouverture des poumons au moment de la naissance.

Au départ, la pression exercée est douce. Il s'agit de retrouver progressivement un espace où le poumon peut s'organiser et retrouver sa liberté. Entre la **plèvre viscérale** et la **plèvre pariétale**, il existe une rencontre entre la trachée, la bronche et le tissu bronchique aérien, qui contient de l'air et un volume résiduel, ainsi qu'un espace liquidien.

Il est important de noter que ce tissu peut abriter des émotions, comme une **tristesse** intériorisée. Par exemple, un enfant qui pleure dans ses poumons ou qui souffre de bronchites peut exprimer une tristesse qu'il ne sait pas verbaliser. En travaillant doucement sur ce tissu, il est

possible d'initier un dialogue et un échange **oxydatif tissulaire**.

À travers la **grande cissure postérieure**, on peut accéder à des espaces où des émotions sont cachées. Il est essentiel de laisser le corps travailler et de se concentrer sur l'axe de réorganisation. Les **récessus costopleuropulmonaires** sont des sacs d'accumulation d'exsudats, où les déchets des poumons se déposent. Ces zones, souvent moins mobiles, nécessitent d'être dynamisées et libérées.

Il est également crucial de dégager les poumons par rapport à leurs points d'attache, notamment les **ligaments suspenseurs du dôme pleural**. Les récessus, comme les **récessus costodiafragmatiques** et le **récessus frémomédiostinal**, jouent un rôle important dans la liberté du médiastin et du cœur.

La production de liquide amniotique commence dès la **cinquième semaine** de grossesse et se développe jusqu'à la **38e semaine**, avec l'apparition du surfactant autour de la **25e semaine**. Les pathologies pulmonaires, telles que la bronchite ou la bronchiolite, peuvent être des manifestations cherchant à résoudre des problèmes non exprimés durant le stade embryonnaire, se manifestant sous forme de **liquide**. On peut dire que l'on "pleure dans les poumons".

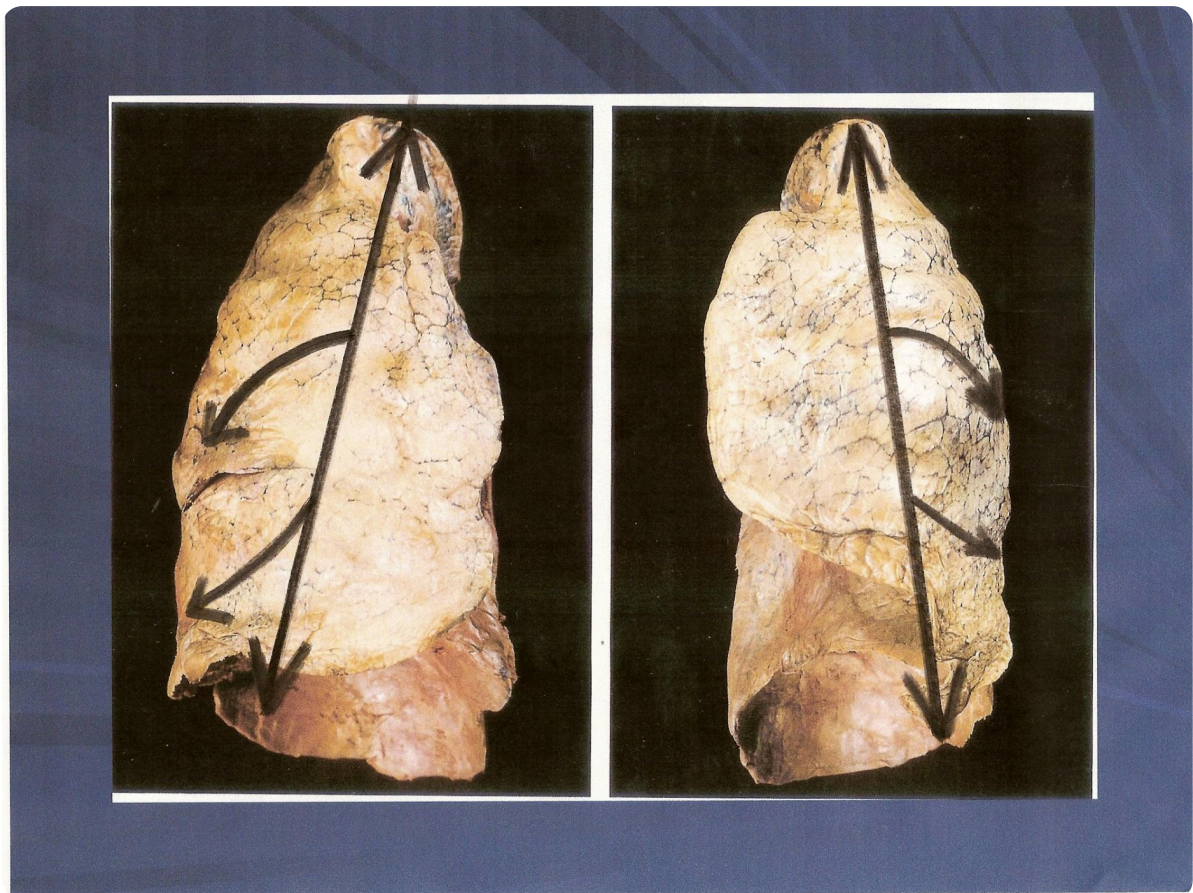


FIG. — Lobe supérieur oblique

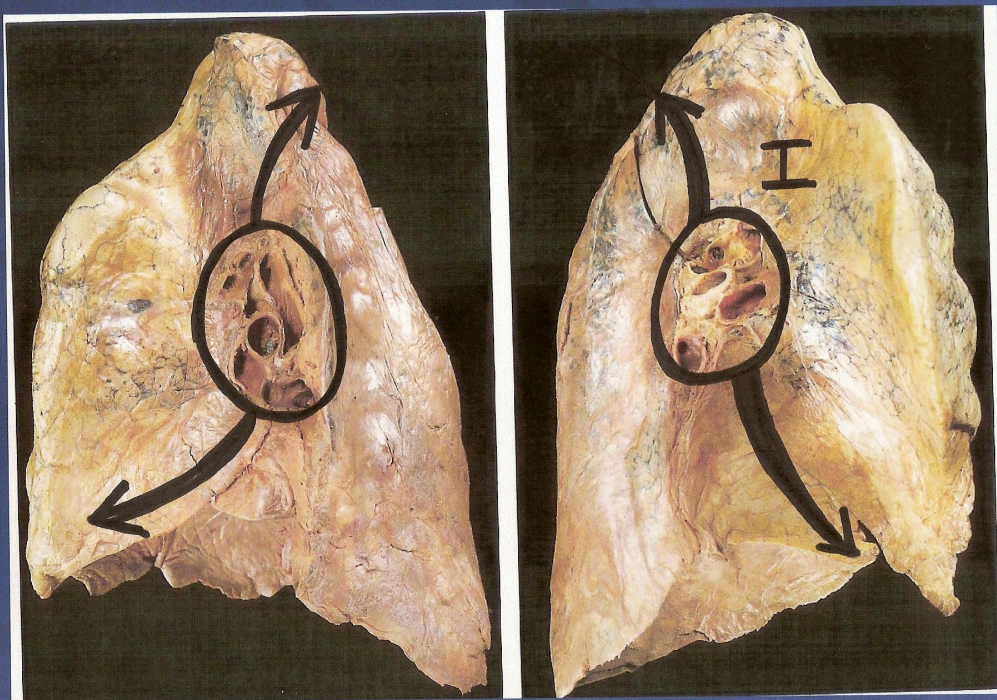


FIG. — Cystic lung disease